

Sa tạng chậu (POP) xảy ra khi phần nâng đỡ xung quanh các tạng chậu — bàng quang, tử cung hoặc trực tràng — bị suy yếu, khiến một hoặc nhiều tạng lồi vào hoặc ra khỏi âm đạo. Điều này gây ra **khối phồng hoặc cảm giác nặng tức**. Đây là tình trạng rất phổ biến, **không nguy hiểm và không phải ung thư**, và có nhiều lựa chọn từ bài tập đến thiết bị hỗ trợ đến phẫu thuật.

Về tình trạng này

Sa được đặt tên theo thành bị tụt:

- **Thành trước** (bàng quang) — sa bàng quang (cystocele)
- **Thành sau** (trực tràng) — sa trực tràng (rectocele)
- **Đỉnh** (tử cung, hoặc đỉnh âm đạo sau khi cắt tử cung)

Triệu chứng thường gặp:

- **Khối phồng hoặc cục** có thể thấy hoặc cảm nhận ở cửa âm đạo
- **Áp lực hoặc nặng tức** vùng chậu, thường nặng hơn vào cuối ngày hoặc khi nâng vật nặng
- Khó đi tiểu hoặc đại tiện hết; đôi khi cần ấn vào khối phồng để đi ("nẹp tay")

Nguyên nhân

Bất cứ điều gì làm căng hoặc suy yếu phần nâng đỡ sàn chậu:

mang thai và sinh con, mãn kinh và lão hóa, rạn mẩn tính (táo bón hoặc ho), nâng vật nặng, phẫu thuật vùng chậu trước đó, thừa cân và yếu tố gia đình.

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

Sa (Prolapse)

Khi tạng chậu tụt khỏi vị trí bình thường.

Cystocele

Bàng quang phồng vào thành trước âm đạo.

Rectocele

Trực tràng phồng vào thành sau âm đạo.

Đỉnh âm đạo

Phần trên của âm đạo, có thể tụt sau khi cắt tử cung.

Vòng nâng (Pessary)

Dụng cụ đặt trong âm đạo để giữ tạng ở đúng vị trí.

Nẹp tay (Splinting)

Dùng tay ấn vào khối phồng để giúp đi tiểu hoặc đại tiện.

Sàn chậu

Các cơ nâng đỡ tạng chậu.

POP-Q

Thang đo dùng để đánh giá mức độ sa.

TÔI CÓ PHẢI ĐIỀU TRỊ KHÔNG? Chỉ khi nào tình trạng làm phiền bạn. Sa tạng chậu không nguy hiểm, vì vậy nếu triệu chứng nhẹ bạn có thể theo dõi. Khi ảnh hưởng đến sự thoải mái hoặc cuộc sống hàng ngày, bạn có thể chọn từ nhiều phương pháp hiệu quả — không có câu trả lời “đúng” duy nhất, và bạn có thể thay đổi quyết định theo thời gian.

Chẩn đoán như thế nào

- **Khám vùng chậu**, thường khi đứng hoặc rặn, để xem thành nào tụt và tụt bao nhiêu
- Đánh giá các triệu chứng bàng quang và ruột
- Đôi khi **kiểm tra chức năng bàng quang** nếu bạn cũng bị tiểu không kiểm soát

Điều trị như thế nào (Từng bước)

- 1 **Theo dõi** nếu không gây khó chịu, kết hợp phòng ngừa (điều trị táo bón, tránh nâng vật nặng, kiểm soát cân nặng).
- 2 **Bài tập cơ sàn chậu / vật lý trị liệu** cho sa nhẹ.
- 3 **Vòng nâng (pessary)** — dụng cụ hỗ trợ tháo lắp được, giảm khối phòng mà không cần phẫu thuật.
- 4 **Phẫu thuật** — sửa chữa để phục hồi nâng đỡ, đóng âm đạo (colpocleisis), hoặc treo tạng. Mỗi loại có tờ thông tin riêng.

Sống chung với tình trạng này

- Giữ phân mềm và **tránh rặn**; không nâng vật nặng hơn mức nhóm chăm sóc khuyến nghị.
- Tập bài tập cơ sàn chậu; kiểm soát ho và cân nặng.
- Vòng nâng có thể là giải pháp lâu dài, không chỉ tạm thời.

Hãy gọi cho nhóm chăm sóc nếu bạn có:

- Bạn **không thể đi tiểu** hoặc đại tiện
- Khối phòng trở nên **đau, chảy máu hoặc lở loét**
- Sốt, hoặc không thể đẩy khối phòng trở lại

BA ĐIỀU CẦN NHỚ

1. Sa tạng chậu là tình trạng phổ biến, không nguy hiểm khi tạng chậu tụt xuống gây khối phòng hoặc áp lực.
2. Chỉ điều trị khi tình trạng làm phiền bạn — lựa chọn từ theo dõi và tập luyện đến vòng nâng hoặc phẫu thuật.
3. Tránh rặn và nâng vật nặng. Tìm chăm sóc ngay nếu không thể đi tiểu hay đại tiện, hoặc khối phòng đau hay lở loét.